PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PRECLINICO

Proteggere il presente, preparare il futuro

Programma di monitoraggio per portatori asintomatici di mutazioni nel gene della proteina prionica

Avere informazioni sulla propria genetica è un atto di coraggio. Questo sito è pensato per accompagnarLa: spiegarLe cosa significa essere portatore o portatrice, perché un monitoraggio periodico è uno strumento efficace, e quali possibilità offre il prossimo futuro

01

Comprendere il Suo punto di partenza

Cosa significa essere portatore o portatrice

Lei è portatore o portatrice di una variante genetica (chiamata anche mutazione – un cambiamento nel DNA rispetto alla maggioranza della popolazione) che può essere associata allo sviluppo di una malattia prionica ereditaria. Questo significa che esiste un rischio aumentato, non una certezza. Molte persone con questa predisposizione genetica vivono decenni senza sviluppare alcun sintomo, e la scienza avanza a ritmo serrato verso trattamenti preventivi.

Essere portatore o portatrice non è lo stesso che avere la malattia. È una predisposizione che Le fornisce informazioni preziose — e queste informazioni possono, se ben utilizzate, trasformarsi in un reale vantaggio.

- **Non tutti i portatori sviluppano sintomi.** La penetranza — ovvero la probabilità che la mutazione finisca per scatenare la malattia — è elevata, anche se l'età di insorgenza varia notevolmente a seconda della mutazione specifica e di altri fattori individuali che ancora non conosciamo.

- **Sapere è potere.** Conoscere il proprio stato genetico Le permette di prendere decisioni informate, pianificare il futuro e accedere a programmi di monitoraggio specializzati.

- **La scienza non si ferma.** Non c'è mai stata tanta ricerca attiva sulle malattie prioniche come oggi. Ci troviamo in un momento decisivo per lo sviluppo di terapie preventive.

02

Perché il monitoraggio è importante

Quattro ragioni per partecipare a un programma di monitoraggio preclinico

I programmi di monitoraggio per portatori asintomatici non sono solo uno strumento di ricerca e sorveglianza medica. Sono una piattaforma di preparazione attiva — per Lei e per tutte le persone che verranno dopo di Lei – di fronte alle terapie preventive in via di sviluppo.

Rilevamento precoce

Rilevamento precoce: se dovessero comparire sottili cambiamenti biologici, questi verrebbero individuati nel momento più favorevole (prima della comparsa dei sintomi) per poter intervenire con i mezzi disponibili.

Accesso prioritario

Accesso prioritario: i partecipanti ai programmi di monitoraggio sarebbero nella posizione migliore per accedere a nuove terapie preventive quando gli studi clinici apriranno le loro porte, poiché si disporrebbe di più informazioni rispetto ad altri portatori.

Informazioni reali

Il monitoraggio periodico fornisce dati oggettivi sulla salute del Suo cervello e sostituisce l'incertezza con una conoscenza fondata. Sono informazioni a cui può accedere o che può ancora non voler conoscere.

Contributo collettivo

La Sua partecipazione aiuta a comprendere meglio la malattia e accelera lo sviluppo di trattamenti per Lei e per le generazioni future.

03

Due realtà all'interno dello stesso profilo

Non tutti i portatori asintomatici si trovano nello stesso momento

All'interno del gruppo dei portatori asintomatici, la ricerca attuale permette di identificare due situazioni chiaramente distinte, anche se in entrambi i casi la persona non presenta sintomi clinici:

Portatore/portatrice in fase inattiva

Il processo biologico associato alla mutazione non mostra segni di attività rilevabile con le tecniche attuali. Questo è associato a un orizzonte temporale più ampio prima della possibile comparsa dei primi sintomi.

Portatore/portatrice in fase attiva silente

Esiste un'attività biologica incipiente — senza sintomi clinici— che le tecniche specializzate possono iniziare a rilevare. Questo profilo è associato a un orizzonte temporale più vicino, anche se non sappiamo ancora quanto e se ci sia una grande variabilità tra i portatori, dal rilevamento dell'attività biologica allo sviluppo dei primi segni. Tuttavia, questo gruppo ha la maggiore probabilità di poter accedere ai primi studi clinici preventivi.

Scoprire in quale di queste situazioni si trova è volontario. Il programma di monitoraggio Le offre la possibilità di saperlo — sempre con accompagnamento e senza pressioni.

04

Ciò che si profila all'orizzonte

Terapie in via di sviluppo e primi studi clinici

Non ci sono mai state tante strategie terapeutiche attive contemporaneamente per le malattie prioniche. Diverse hanno già mostrato risultati promettenti in modelli animali, e alcune hanno iniziato a fare il salto verso studi con esseri umani. Questo non garantisce che tutte funzionino nell'uomo, ma segna un cambiamento storico: per la prima volta esistono diverse vie reali che lavorano in parallelo verso futuri trattamenti preventivi e modificanti della malattia.

COSA SIGNIFICA OGNI SITUAZIONE

Studio clinico in corso

Viene già testato sugli esseri umani.

Studio clinico registrato, inizio in attesa

Lo studio è definito e approvato/registrato, ma non ha ancora iniziato il reclutamento o il trattamento.

Sviluppo preclinico

La terapia ha mostrato attività in laboratorio e/o negli animali, ma non è ancora stata testata sull'uomo.

Studio clinico in corso (Fase 1/2a)

Oligonucleotidi antisenso (ASO)

Sono molecole sviluppate per ridurre la produzione della proteina prionica. In modelli animali, l'abbassamento di questa proteina ha ritardato l'insorgenza della malattia e prolungato la sopravvivenza. Questa strategia viene già valutata in uno studio clinico internazionale su persone con malattia prionica sintomatica.

Studio clinico registrato, inizio in attesa (Fase 1)

Interferenza dell'RNA (siRNA)

Queste molecole "silenziano" il messaggio genetico che porta alla proteina prionica. Negli animali sono state ottenute riduzioni profonde e durature di questa proteina, con effetti positivi sul decorso della malattia. Inoltre, esiste già un primo studio clinico di Fase 1 registrato per questa strategia, anche se il reclutamento non è ancora iniziato.

Sviluppo preclinico

Piccole molecole a somministrazione orale

Si stanno sviluppando composti in grado di ridurre la quantità di proteina prionica che la cellula produce. Il loro grande potenziale vantaggio consiste nel fatto che potrebbero essere somministrati come semplici trattamenti a lungo termine. I dati finora pubblicati mostrano risultati promettenti negli animali, ma questa via non è ancora passata agli studi clinici.

Sviluppo preclinico

Terapie geniche

Comprendono strategie di silenziamento permanente e di editing molecolare orientate a spegnere o ridurre in modo duraturo il gene della proteina prionica. In modelli animali si è già ottenuta un'ampia riduzione della proteina e un significativo prolungamento della sopravvivenza. Alcuni programmi avanzano verso la clinica, ma attualmente si trovano ancora in fase preclinica.

Essere iscritti a un programma di monitoraggio La porta in prima linea per partecipare a questi studi, qualora si svolgano in Spagna. La finestra di opportunità si sta aprendo — e coloro che sono già in monitoraggio avranno le maggiori possibilità di attraversarla per primi.

05

Cosa comprende il monitoraggio

Il protocollo di visite periodiche

Il programma consiste in visite periodiche — solitamente annuali o semestrali — presso un centro specializzato. Ogni visita è progettata per essere il più confortevole ed efficiente possibile, sempre con il supporto di un'équipe dedicata.

Valutazione neurologica e neuropsicologica

Esame clinico dettagliato e batteria di test cognitivi per determinare e monitorare il Suo valore di riferimento individuale.

Biomarcatori nel sangue, nel liquido cefalorachidiano e nella pelle

Analisi del sangue e, se indicato, puntura lombare e/o biopsia cutanea con punch per misurare proteine specifiche che riflettono lo stato neurobiologico.

Studio del sonno

Mediante la polisonnografia registriamo ciò che avviene durante il sonno: movimenti, respirazione, attività cerebrale e comportamento. Alcuni disturbi del sonno – in particolare quelli legati alla fase REM – possono manifestarsi in modo sottile, soprattutto nei portatori di Insonnia Familiare Fatale, prima che compaiano i primi sintomi.

Diagnostica per immagini ad alta risoluzione

Risonanza magnetica del cervello, che permette di rilevare cambiamenti strutturali o funzionali prima che siano clinicamente riconoscibili.

Supporto psicologico

Accompagnamento emotivo e orientamento specializzato, disponibile a ogni visita e accessibile tra una visita e l'altra quando necessario.

Informazioni sulle novità terapeutiche

Aggiornamento periodico sugli studi clinici disponibili o in preparazione per cui potrebbe essere idoneo/a, con orientamento personalizzato per ogni occasione.